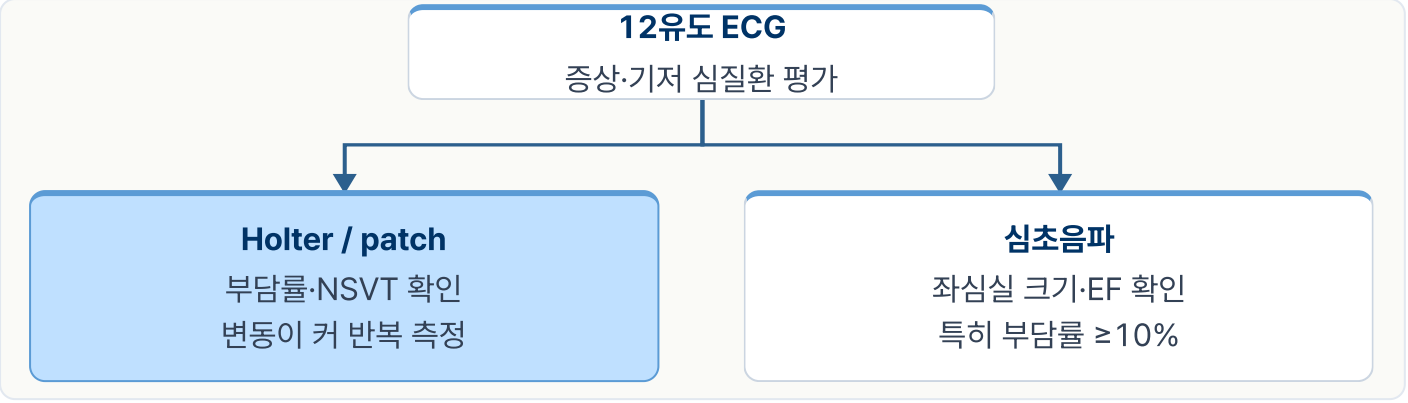
의료진 진료 카드 · ASL-003

PVC · 평가와 의뢰

심실조기수축(PVC)은 기저 심질환, 증상, 부담률(burden), 좌심실 크기·EF를 함께 본다.

PVC 발견 후 · 부담률과 심기능을 연결



추적 강도를 정하는 두 축

기저 심질환	관상동맥질환·과거 심근경색 등 기저 심질환이 있으면 예후가 나쁘다. 기저 심질환이 없는 경우 전반적 예후는 양호하다.
부담률	과거 20~25%를 강조했으나 최근에는 약 10%부터 위험 증가, 일부 6~8%에서도 가역적 PVC 심근병증 보고. 절대 경계값보다 연속적인 위험으로 이해한다.
심초음파	부담률 ≥10%이면 EF뿐 아니라 좌심실 확장도 살핀다. ≥20%이면 심근병증 가능성이 높아 더 적극적으로 추적한다.

연자 Q&A · 상급병원 평가를 연결할 때

의뢰 단서	증상, 부담률 증가, 좌심실 확장·EF 감소, 다형성 PVC 또는 NSVT.
증상과 위험	실신·전실신, 심한 흉통·호흡곤란, 구조적 심질환·심부전·심근경색 의심, 유의한 부정맥 기록이면 의뢰한다.

PVC는 무증상부터 맥이 건너뜀·철렁함·느리게 느껴지는 맥·가슴 답답함·피로·기침·소화불량·호흡곤란까지 다양하다. 증상 표현만으로 부담률이나 심기능을 판단하지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-003

PVC · 증상 치료와 약제 선택

연자 Q&A의 약제 예시. 부담률만으로 치료를 결정하지 않고 증상과 좌심실 재형성을 함께 본다.

연자 Q&A · 치료 목적을 먼저 구분

EF·좌심실 크기 정상

5~10%라도 증상이 크지 않으면 항부정맥제를 반드시 시작하지 않는다. 낮은 부담률의 치료 목적은 주로 증상 완화.

재형성이 진행하는 경우

좌심실 확장, EF 감소, 새 MR·TR 또는 증상이 있으면 치료 고려. BB 실패와 좌심실 기능저하가 함께 있으면 전문센터에서 약제·절제술을 결정.

연자 Q&A · 증상성 PVC 약제 예

우선 시도	구조적 심질환이 없고 부담률이 낮으면 저용량 BB: bisoprolol 1.25~2.5 mg/day 또는 metoprolol 계열. 좌심실 기능이 정상이면 verapamil·diltiazem도 선택.
Class Ic	구조적 심질환·CAD를 배제하고 12유도 ECG 확인 후 고려. flecainide 50mg bid부터, propafenone 150mg tid 또는 서방형 225mg bid의 저용량 예시. QRS widening과 증상을 보며 조절.
기타 약제	연자는 propafenone·flecainide·pilsicainide 및 amiodarone도 언급. 혈압·맥박·증상과 개인별 반응으로 지속 여부를 결정한다고 답변했다.

연자 Q&A · 기능저하와 절제술

뚜렷한 기능저하	명확한 좌심실 수축기 기능저하 또는 허혈성 반흔이면 일반적으로 class Ic를 피한다. HFrEF에서 amiodarone을 고려하나 장기 독성도 함께 평가.
의뢰·절제술	고부담률과 기능저하가 있으면 여러 약제를 바꾸기보다 절제술을 적극 고려. 약물 불응·심부전 동반은 본강의의 절제술 연결 조건.

연자 Q&A: 증상이 일상을 크게 방해하고 초점이 명확하면 낮은 부담률에서도 절제술 논의가 가능하지만, 국내 PVC burden 15% 기준과 약물 불응·일상생활 지장의 객관적 자료를 언급했다. 이는 연자의 당시 급여 설명이다.

의료진 진료 카드 · ASL-003

PVC · 반복 측정과 장기 추적

현재 수치가 낮아도 변화할 수 있다. 심초음파의 좌심실 크기와 EF 변화를 함께 추적한다.

가역적 심기능 저하를 놓치지 않는 추적



연자 Q&A · 검사 여건과 추적

10초 ECG만 가능	24시간 부담률을 정확히 추정하기 어렵다. 서로 다른 날·시간대의 반복 ECG, 촉진상 빈번한 조기수축, wearable·handheld ECG는 보조 단서.
정량 평가	심근병증 위험을 판단할 정도로 잦으면 24~48시간 Holter 또는 더 긴 patch monitoring을 연결한다.
부담률 ≥10%	현재 재형성이 없어도 1~2년에 한 번 echo로 좌심실 크기·EF·새 MR/TR을 확인한다. 낮은 초기 부담률도 본강의는 한두 번 반복 Holter로 낮게 유지되는지 보도록 설명.

본강의 · 연구와 관찰의 맥락

기저 심질환 없는 군	1985년 연구: 평균 566 PVC/시간(범위 78~1994/시간), 부담률 약 2~48%. 무증상·건강한 군의 장기 사망 위험은 일반인과 차이가 없었다.
연자 관찰	부담률 ≥10% 환자를 5~10년 추적해도 심한 기능저하(EF 약 45%·40% 이하)는 약 5%, 10%를 넘지 않는다는 연자의 경험적 설명. 고부담률 모두가 심부전이 되는 것은 아니다.

본강의의 반복 Holter 자료: 부담률 <1% / 1~10% / ≥10% 비율은 기저 90.1% / 6.7% / 3.2%, 추적 95.3% / 3.6% / 1.1%. 개인별 부담률이 오르내리므로 한 번의 값만으로 추적을 끝내지 않는다.